

DPOC · exacerbação aguda

Exacerbação de DPOC = piora aguda de dispneia, tosse ou escarro. Trate broncoespasmo e inflamação; reserve antibiótico para critérios de Anthonisen ou pneumonia.

Antibiótico — quando

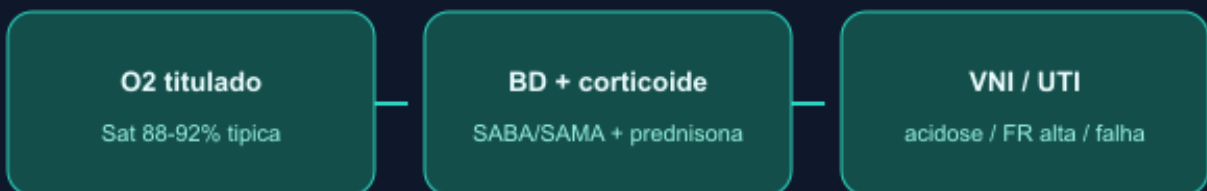
Dica - Antibiótico — quando

Indique se "e 2 critérios de Anthonisen (!'dispneia, !'volume, !'purulência do escarro), especialmente com escarro purulento, ou se houver pneumonia / ventilação mecânica.

Fluxo clássico: oxigenar com alvo !' broncodilatar + corticoide !' decidir VNI/UTI.

Exacerbacao de DPOC

Da porta a decisao de suporte



Tratamento farmacológico

- Broncodilatadores de curta ação: SABA ± SAMA em nebulização/inalação seriada
- Corticoide sistêmico curto (ex.: prednisona 40 mg/dia por ~5 dias) — evita curso longo
- ATB empírico conforme gravidade/Pseudomonas de risco (hospitalizações, DPOC grave)
- Suspende sedativos e corrige precipitantes (IC, embolia, pneumotórax)

VNI — indicações clássicas

Critério | Alvo / nota

Acidose respiratória | pH ~7,25–7,35 com hipercapnia

Dispneia intensa / FR alta | Fadiga muscular iminente

Contraindicações | PCR, vômitos, instabilidade grave, via aérea insegura

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não oxigene 'a 100% sem alvo' no DPOC hipercápnico crônico. Titule SatO₂ , ~88–92% e reavalie gasometria — hipóxia mata, mas hiperóxia pode piorar hipercapnia.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1